EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79405
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2024-02-22 09:26:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VICTOR ORLANDO PALAVECINO JELDRES			RUN	: 6.910.313-8
F.Nac	: 11-08-1952	Edad	: 71 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: V MACKENNA 029			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-16	Fecha Egreso	: 2024-02-22 09:26:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. L03.9-CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Medicina Interna
Epicrisis.

Diagnosticos de egreso

1) Celulitis EII en tratamiento
2) Ulcera varicosa EID en tratamiento con miasis, retirada por cirugia.
---Cultivo Pseudomonas Suceptible a Carbapenemicos.
3) Onicomicosis bilateral (micosis cutanea interortejo)
4) HTA
5) Cardiopatia isquemica
6) ICC
7) AEOC
8) FA cronica
9) ERC etapa IIIa (crea basal 1.4 , VFG habitual 45)
10)LRA KDIGO 1 en recuperacion , multifactorial.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L03-CELULITIS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Ingresa a nuestro servicio para tratamiento de patologia infecciosa.
Regular evolucion ambulatoria por lo que se hospitaliza.
Evaluado por cirujano , sin conducta quirurgica, solo aseo curacion y atb.

Cultivo herida anterior : SAMR / Pseudomonas MS / Enterococcus Faecalis MS

Laboratorio:
PCR 134 / Crea 1.2 VFG 59 / Glicemia 103
GB 12400 / PL 247000 / HB 12
INR 1.15

Se procede a inicio de ATB con Imipenem ev + Coptrimoxazol oral.
Dado de alta por cirugia el dia 21.2.24
Actualmente solo con tratamiento antibiotico y curaciones por celulitis y ulcra varicosa.
Falla renal en franca recuperacion, creatinina actual 2.0.
Deambula , buena tolerancia oral.
Parametros inflamatorios en franco descenso actualmente 39

-PA 128/67 FC 66x Sat 94% Ambiental
-Bien perfundido.
-Yugulares Planas
-Cardiopulmonar sin cambios desde su ingreso
-Abdomen BDI
-EII con notable mejoria de eritema y edema subcutaneo, sin dolor , sin lesiones ulcerosas, celulitis en franca regresion.
-EID con notable mejoria de eritema y edema subcutaneo , ulceras con bordes vitales , sin secrecion , mantiene lesiones descamativas compatibles con micosis.

Laboratorio
-Crea 2.0 (anterior 2.3) VFG 33
-PCR 39 Na 137 / K 4.3 / CL 104
-GB 11000 PCR 39 (anterior 75)

Cultivo:
-Pseudomonas Suceptible a carbapenemicos.

PLAN DE MANEJO:

Plan:
Manejo en Hodom con curaciones + tratamiento Antibiotico
Mantener farmacos cronicos.

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones
2. -Reposo Relativo , pierna en alto
3. -Mantener regimen hiposodico y diabetico
4. -Cotrimoxazol forte 2 cada 12 horas vo , completar 10 dias al menos , de acuerdo a evolucion (27.2.24)
5. -Meropenem 1g ev cada 12 horas (completar 10 dias al menos 27.2.24 , observando evolucion.)
6. -Iniciar Terbinafina 250mg al dia , control con hoja hepática en 1 mes. Debe mantener el tratamiento entre 12 a 16 semanas
7. -Control funcion renal y electrolitos en 48 horas. 24.2.24

8. -Curaciones por enfermeria segun indicacion de cirugia.
9. -Mantener tratamiento cronco.
10. -Control SOS en Urgencias
11. -Mantener controles en atencion primaria por ulcera
12. -Controles habituales en nuestro centro por patologias cronicas.

Control en: 15 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO